



Facultad de Economía y Administración

¿Reduce la exposición a la democracia la desigualdad en salud en Latinoamérica?

Luca Armelini
12/11/2024

Resumen Ejecutivo

Este informe analiza cómo la exposición a la democracia afecta la desigualdad en salud en Latinoamérica, siguiendo el marco planteado por Costa-Font y Knust (2023) para Europa. Aunque la democracia tiende a reducir la desigualdad en salud al mejorar las condiciones de quienes están en peor estado, este estudio examina si estos efectos se replican en América Latina, un continente con niveles de desigualdad (coeficiente de Gini más bajo) y corrupción más altos que en el continente europeo. Así, empleando como variable dependiente la Salud Autoevaluada del 1 al 5 (convertida al índice de Cowell-Flachaire) recopilada por el World Value Survey y los años de democracia como variable regresora, se procede a calcular el efecto de la exposición a la democracia en la distribución de salud de cada país y año. Los resultados muestran un efecto dual: la democracia disminuye la desigualdad en salud entre los individuos en peor estado, pero aumenta las disparidades entre aquellos en mejores condiciones de salud. Además, factores de gobernanza como la estabilidad política en Latinoamérica y la voz y rendición de cuentas a nivel global influyen en estos resultados.

Introducción

La motivación de este informe es observar como la exposición a la democracia afecta la distribución de salud de los países Latinoamericanos, con un especial enfoque en las desigualdades que presenten dichas distribuciones. La relación entre dichas variables ya está documentada por Costa-Font y Knust (2023). Ellos encuentran que, para el caso de Europa, una mayor exposición a la democracia reduce tanto la desigualdad univariada (-0.0006 y -0.0002) en salud, medida por el índice de Cowell-Flachaire, como la desigualdad bivariada (-0.000246) en salud, referida a la relación de la salud con el rango de ingresos en que se encuentran los individuos.

No obstante, analizar el caso Latinoamericano puede resultar interesante porque se están analizando países sumamente distintos a los de Europa, en cuanto a sus niveles de ingreso, desigualdad, corrupción y gobernanza. Esto lleva a la pregunta sobre si los mecanismos bajo los cuales la democracia reduce la desigualdad en salud en Europa pueden llegar a ser efectivos en Latinoamérica, considerando que los mencionados podrían llegar a ser inhibidos por una serie de factores a los cuales Costa-Font y Knust (2023) llaman “Trampa de desigualdad en la salud”.

Revisión de Literatura

Democracia y su influencia en la distribución de la salud

En una primer instancia, es preciso analizar bajo que canales de transmisión logra la democracia afectar la distribución de salud de una sociedad. Se observan diversos canales mediante lo cual esto ocurre.

En primer lugar, Costa-Font y Knust (2023) proponen que, en las democracias, los incentivos implícitos de reelección provocados por la competencia electoral pueden incrementar la recepción a las demandas populares por parte de los agentes políticos, en especial los de aquellas minorías significativas que en otras formas de gobierno serían

ignoradas. Esto es consistente con lo propuesto por Acemoglu, Robinson y Restrepo (2013) siguiendo el modelo de Meltzer y Richard (1981). La democratización, al extender el poder político a los sectores más pobres de la sociedad, va a incrementar la tendencia a políticas públicas favorables a estos grupos, lo que se asocia a una mayor redistribución y consecuentemente una menor desigualdad, lo que incluye rubros como el de salud.

Besley y Kudamatsu (2006) exploran la relación entre democracia y resultados de salud en varios países. Examinan si las instituciones democráticas impactan positivamente la expectativa de vida y las intervenciones de salud pública. Encuentran que las democracias tienden a tener mejores resultados de salud en la forma de una mayor expectativa de vida y menor mortalidad que las autocracias. En este sentido, subrayan que una de las diferencias que explica las variaciones en los resultados de salud es la mayor representatividad que tienen las democracias. Esto se traduce en que respondan a una base más amplia de ciudadanos y que por tanto tengan que priorizar la salud pública, lo que beneficia a aquellos en los sectores de mayor pobreza y peor salud, quienes hacen uso de este tipo de servicios. Esto se traduce en que este tipo de personas no quede tan rezagada respecto al resto de la población.

Matsuura (2015) investiga si la introducción de provisiones constitucionales referentes a la salud en un país democrático como Estados Unidos logran mejorar los resultados de salud y hacer a los sistemas de salud más equitativos instando a los responsables políticos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entre sus resultados, encuentra que la introducción de un mayor compromiso constitucional que obligue al estado a proveer salud dirigida a los sectores más pobres lleva a una reducción de la mortalidad infantil del 6,5% en este sector, lo que sugiere que las garantías constitucionales características de muchas democracias logran reducir las desigualdades a las que pueden estar suscritos los sectores indigentes y más desfavorecidos de la distribución. La reducción de la mortalidad infantil se vincula con una baja en la desigualdad en salud en cuanto la democracia permite mejorar la situación de aquellos

que se encuentran en la cola de la distribución, en este caso niños en riesgo de muerte, y por tanto reduce la desigualdad de este grupo respecto al resto de la población. Además, el autor agrega que el sistema democrático, en su faceta de ser un proceso colectivo que añade distintas voces, información y perspectivas al debate público, logra que las reducciones en las tasas de mortalidad infantil al introducir derechos constitucionales sean causadas por un compromiso social (monitoreo, investigación, trabajo social) más que por un compromiso del gobierno con el propio derecho.

CEPAL (2023) presenta un estudio en el que se analizan programas de transferencia condicionales, como es el caso del “Bolsa Familia” en Brasil. Se destaca que los regímenes democráticos en Latinoamérica han implementado políticas redistributivas que mejoran significativamente los resultados de salud para los segmentos más pobres de la sociedad, lo que lleva a una mejoría en el problema que representan las desigualdades en salud en el continente.

Por último, Costa-Font y Knust (2023) explican sus resultados en cuanto a la reducción de desigualdad de salud bajo la premisa de que las democracias son más propensas a desarrollar objetivos y programas de salud pública que apunten a ayudar a individuos que exhiben las mayores necesidades en materia de salud. Esto es consistente con lo encontrado por Costa-Font, Turati y Batinti (2020), dónde se encuentra que las democracias fomentan programas que mejoran la salud de aquellos en lo más bajo de la distribución de salud mediante el acceso universal a la salud y objetivos de salud pública.

En síntesis, la democracia logra afectar la distribución de salud de una población porque logra mejorar la situación de aquellos que se encuentran en la parte inferior de la distribución, a quienes Costa-Font y Knust (2023) describen en situación de “pobreza de salud”.

Trampa de desigualdad de salud y relevancia del caso Latinoamericano

No obstante, en las democracias también se pueden suceder las denominadas “trampas de desigualdad de salud” (Costa-Font y Knust, 2023). Las decisiones democráticas pueden no lograr responder a las necesidades de determinadas minorías cuando el gobierno en cuestión se encuentra manejado por poderosas élites (Powell-Jackson et al. 2011).

Además, en sociedades más desiguales, el votante mediano puede no estar interesado en políticas que enfrente los riesgos de salud que ciertas minorías puedan sufrir, lo que puede resultar en crecientes disparidades de salud (Powell-Jackson et al. 2011). Los gobiernos pueden ser también menos redistributivos si las élites políticas son exitosas en controlar la voluntad de la clase media (Acemoglu y Robinson, 2005). Por último, las democracias pueden caer en corrupción o nepotismo, lo que no necesariamente beneficia a los más vulnerables (Krueger et al. 2015).

En este contexto, es interesante analizar como varían los resultados propuestos por Costa-Font y Knust (2023) para el caso Latinoamericano. Es que en dicho continente se observan coeficientes de Gini que oscilan entre 37 y 54,8 puntos (World Bank Data). El coeficiente de Gini de la Unión Europea fue de 29,2 puntos en 2022 (EuroStat, 2022). Por otro lado, al observar los resultados del Corruption Perceptions Index (Transparency International, 2023), que califica a los países de los más corruptos a los más limpios, se muestra que en Latinoamérica los puntajes percibidos, a excepción de Chile y Uruguay, son bastante bajos. Brasil presenta 36 puntos, Perú 33 y países como Nicaragua o Venezuela llegan a los 17 y 13 puntos, respectivamente. Por otro lado, en Europa los países suelen superar los 50 puntos, llegando casi a 90 en regiones como Escandinavia, lo que sugiere un nivel de corrupción promedio mucho menor.

Lo anterior refleja que en Latinoamérica, al estar presentes ciertos factores como pueden ser mayores niveles de desigualdad y corrupción, es probable que se dé la llamada “trampa de desigualdad en salud”, y que los mecanismos bajo los cuales la democracia

logra afectar a la distribución de salud en Europa no sean igual de efectivos al tomar como muestra esta nueva región.

Data y Metodología

El informe en cuestión sigue la metodología propuesta por Costa-Font y Knust (2023). Se emplean los datos del World Value Survey (WVS), encuesta realizada de manera periódica (cada 5 años) que cubre un amplio espectro de países y temas. Específicamente, se hace uso en este informe de la variable “Salud Autoevaluada”, que pregunta a los encuestados “como describirían su estado de salud” en una escala del 1 al 5, dónde 1 representa un nivel muy bajo y 5 uno muy alto. Además, se emplean las edades de los encuestados y el rango de ingresos en el que se encuentran (de 1 a 10) como variables adicionales. Adicionalmente, con el objetivo de medir la exposición a la democracia y establecer variables de control, se recogen datos de Polity V y el Banco Mundial.

Medidas de desigualdad en salud

A diferencia de otras medidas de bienestar, el estado de salud no es algo directamente observable, por lo que se mide empleando indicadores como la tasa de mortalidad, condiciones diagnosticadas o la propia salud autoevaluada. Para este informe se emplea este último indicador. Es que, según lo reportado por Wu (2013), existe una fuerte asociación entre la salud autoevaluada y medidas objetivas de salud, tales como la presencia de enfermedades crónicas, el nivel de presión sanguínea o los montos de colesterol que presenta una persona. Además, encuentra que la salud autoevaluada es una buena predictora de mortalidad y morbilidad, incluso cuando controla por indicadores objetivos de salud. Lo anterior, sumado a la disponibilidad de datos que presenta esta variable, hacen que resulte idónea para el propósito de este estudio.

Costa-Font y Knust (2023) se nutren de dos indicadores para medir el efecto de la exposición de la democracia en la distribución de la salud. Uno es el Concentration Index

(CI), que traza la proporción acumulada de salud en función de la proporción acumulada de la población ordenada por ingresos. El otro es el índice de Cowell y Flachaire (2017), que mide la desigualdad en base a la posición de un individuo en la distribución de los resultados de salud. Para los fines de este informe se procede a explicar y emplear únicamente el segundo indicador.

El enfoque de Cowell y Flachaire (2017) toma en cuenta que los datos de salud pueden agruparse en las categorías $k = 1, 2, \dots, K$ ordenadas de un menor a un mayor estado auto reportado de salud. Se tiene información de la cantidad de personas en cada categoría, n_k , y se busca calcular el estatus de cada persona basado en su posición en la distribución de salud. Hay dos conceptos para calcular dicho estatus:

Uno es el enfoque “hacia abajo”, que calcula el estatus de una persona i considerando cuantas personas están en categorías de salud peores o iguales a la suya:

$$s_i = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{k(i)} n_l$$

Aquí, s_i representa el estatus de salud relativo de la persona i en la distribución de salud de la población, mientras que n es el tamaño total de la población, n_l representa el número de personas en la categoría de salud l y $k(i)$ la categoría de salud en la que se encuentra la persona i . En síntesis, es la suma acumulativa de las personas que están en categorías iguales o peores a la persona i , dividida por el total de la población n . Esto arroja para cada individuo un valor entre 0 y 1. Por otro lado, el enfoque “hacia arriba” sigue la misma metodología, con la diferencia de que calcula el estatus de una persona i considerando cuantas personas están en categorías de salud mejores o iguales a la suya:

$$s'_i = \frac{1}{n} \sum_{l=k(i)}^K n_l$$

Una vez realizado lo anterior, se procede a calcular el índice de desigualdad univariada para cada uno de los enfoques:

$$I_0(S) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(s_i)$$

El índice mide específicamente el promedio de los logaritmos de los estatus de salud de todas las personas de la población. El uso del logaritmo tiene un efecto importante, ya que hace que el índice sea más sensible a los extremos de la distribución de salud para el enfoque “hacia abajo” y “hacia arriba”.

Valores más cercanos a 0 en valor absoluto del índice reflejan una menor desigualdad en la distribución de salud. En este sentido, puede ser de ayuda comparar los resultados evidenciados en la Figura 1 y 2 (Apéndice). En estas, se observan los coeficientes obtenidos por distintos países en la última encuesta realizada por el World Value Survey. Para la Figura 1, que denota el enfoque “hacia abajo”, que Chile tenga un coeficiente de 0,48 implica que entre las personas de peor salud la dispersión no es tan alta. Brasil, por otro lado, cuenta con un coeficiente de 0,54. Esto indica una mayor desigualdad entre las personas con peor salud. Es decir, en Brasil, entre las personas en peores condiciones de salud, algunas están en mucho peor estado que otras. El mismo análisis puede hacerse en el enfoque “hacia arriba”, considerando la desigualdad entre los sectores más favorecidos en la distribución de salud.

Medidas de democracia

Para definir la variable de democracia, se sigue la metodología empleada por Costa-Font y Knust (2023). Ellos emplean el proyecto Polity IV como medida, ya que este evalúa diversas dimensiones a considerar en los gobiernos democráticos que se resumen en una escala que va del -10 al 10, dónde -10 representa una monarquía hereditaria y 10 una democracia consolidada. Particularmente, las democracias se definen en función de tres

componentes esenciales. Primero, la existencia de instituciones y procedimientos mediante los cuales los ciudadanos pueden expresar sus preferencias sobre las políticas y los líderes vigentes. Segundo, el poder ejecutivo necesita estar institucionalmente limitado por un parlamento o poder legislativo. Tercero, las libertades civiles deben estar garantizadas a todos los ciudadanos (Norris, 2012). Según lo propuesto por el Polity IV, un país es definido como democracia en un año determinado si presenta un puntaje de 6 a 10 en la escala (Center for Systemic Peace, 2016).

Por otro lado, Costa-Font y Knust (2023) proponen que si bien el propósito de su estudio es examinar la relación entre democracia y desigualdades en salud, es poco probable que la exposición a la democracia cambie la distribución de la salud de manera inmediata. Por lo anterior, se debe considerar que una democracia se va construyendo en el tiempo en la forma de un “capital democrático” o de la exposición histórica a la democracia (Persson y Tabellini, 2009). Por lo anterior, los autores emplean la cantidad de años que un país es considerado como democracia (según lo propuesto por Polity IV) para medir la “exposición a la democracia” del país en cuestión.

Estrategia Empírica

Dado que el objetivo es analizar como la desigualdad en salud evoluciona respecto a la exposición democrática a lo largo del tiempo, se considera la siguiente ecuación:

$$HI_{ct} = \theta_{ct} + \beta_1 D_{ct} + \beta_2 Latino + \beta_3 D_{ct} * Latino + \gamma X_{ct} + \alpha_t + \epsilon_{ct}$$

HI_{ct} representa en nivel de desigualdad univariada de un país dado en un momento del tiempo t . D_{ct} es la variable que mide la exposición a la democracia del país en el tiempo. El coeficiente β_1 mide como un año adicional de exposición a la democracia afecta la desigualdad en salud. β_2 mide la desigualdad en salud en Latinoamérica respecto al resto del mundo y β_3 el efecto diferencial que podría llegar a tener la exposición a la

democracia en Latinoamérica diferente a los demás países encuestados por el WVS. X_{ct} es un vector de variables de control.

Controles y Variable Instrumental

En lo que respecta a este informe, se buscan emplear diversas variable de control. La primera de ellas es el porcentaje de población mayor a 65 años respecto al total (tener más gente anciana podría implicar una distribución de salud con más gente en una mala situación), el porcentaje de población masculina respecto al total de la población, el PIB per cápita y variables “*dummy*” para distintos shocks que puedan haber afectado la distribución de salud en un momento dado del tiempo. Entre estas últimas, se contabilizan los años en que existieron pandemias según los criterios de la OMS (2024), vale decir, el VIH (1981-), la Gripe Porcina (2009-2010) y el Coronavirus (2020-2022), y los años en que existieron contracciones del PIB per cápita mundial, suceso que el FMI (2015) define como recesión. Adicionalmente, se emplea el promedio de la variable “Satisfacción por la vida” de cada encuesta del World Value Survey, con el objetivo de mitigar el hecho de que algunos países podrían ser más optimistas respecto a su salud que otros.

Además, se consideró emplear el Índice de Gini y criterios de gobernanza propuestos por The Worldwide Governance Indicators (2024) como controles adicionales. El primero se descartó por falta de datos y el segundo debido a que las variables agregadas generaban problemas de multicolinealidad con el regresor independiente. No obstante, en la siguiente sección se evalúan los criterios de gobernanza como variables regresoras para dar una mayor claridad a que componentes específicos de las democracias pueden estar influenciando la distribución de salud. Por último, α_t controla por los factores que van cambiando a lo largo del tiempo.

Una consideración adicional que realizan Costa-Font y Knust (2023) es que pueden existir problemas de endogeneidad. La desigualdad en salud puede tener causalidad inversa en la estabilidad democrática y el término de error. Para resolver esto, el modelo emplea como

variable instrumental la exposición democrática del país 15 años antes. La idea viene de que la experiencia democrática pasada de un país afecta su nivel de democracia actual, pero es poco probable que tenga un efecto directo sobre la desigualdad en salud actual excepto que esta sea por su influencia previa en la democracia actual. Dado que en Latinoamérica es poco común encontrar democracias longevas, para fines de este informe se no se utiliza el instrumento en cuestión.

Resultados

Los resultados presentan variaciones respecto a los distintos controles y metodologías que se emplean. Al observar la Tabla 1, que reporta los resultados de la muestra total (es decir, considera todos los países encuestados en el WVS), se observan coeficientes de -0.0001933 y -0.0002262 (sin y con efecto fijo) en las columnas 1 y 2 para el índice de Cowell-Flachaire hacia abajo. Esto indica que cada año adicional de democracia se asocia con una disminución en el índice de desigualdad para aquellos con peor estado de salud. Por tanto, a lo largo del tiempo, la exposición continua a la democracia puede contribuir a reducir la desigualdad en salud entre los individuos en condiciones menos favorables. Las columnas 3 y 4 reportan resultados positivos y significativos de 0.0001751 y 0.000115 respectivamente para el índice de Cowell-Flachaire hacia arriba. Consecuentemente, un año adicional de democracia se asocia con un aumento en el índice de desigualdad en salud para aquellos en mejor estado. Es decir, en los países democráticos, la desigualdad entre individuos en mejores condiciones de salud podría aumentar con el tiempo.

El coeficiente *Latino* es positivo y significativo para CF hacia abajo (0.0198501 y 0.0189455), por lo que existe un mayor nivel de desigualdad entre las personas con peor salud en Latinoamérica respecto al resto del mundo y negativo para CF hacia arriba, lo que implica lo contrario para la gente en mejores condiciones del salud. La interacción entre democracia y Latinoamérica no es significativa estadísticamente, lo cual indica que no se encuentra evidencia estadística de que el efecto de la democracia en la desigualdad en

salud sea diferente en Latinoamérica en comparación con el resto del mundo. En otras palabras, los años de democracia parecen tener un efecto similar sobre la desigualdad en salud tanto dentro como fuera de Latinoamérica.

Respecto a las variables de control, se observan porcentajes positivos en la desigualdad en salud tanto para el porcentaje de personas mayores a 65 años y los años en que existieron recesiones del PIB per cápita mundial, aunque este último solo tenga impacto en el índice hacia abajo. El PIB per cápita y la Satisfacción por la Vida (hacia abajo) afectan negativamente el índice de Cowell-Flachaire, lo que indica que estas variables presentan correlación con una menor desigualdad en salud. La pandemia y el porcentaje de población masculina no son significativas al 10%. El r^2 ajustado es más alto cuando se considera CF hacia abajo, lo que sugiere, en congruencia con Costa-Font y Knust (2023), que el modelo explica mejor la variación de la desigualdad en la parte baja de la distribución de salud. Se desprende de esta tabla que la democracia parece tener un efecto dual sobre la desigualdad en salud. Mientras que reduce la desigualdad para aquellos en peor estado de salud (hacia abajo), aumenta la desigualdad entre aquellos en mejor estado de salud (hacia arriba).

La tabla 2 evalúa como ciertas variables de gobernanza, extraídas de The Worldwide Governance Indicators (2024), podrían afectar la distribución de salud tanto a nivel global como en Latinoamérica. Dichas variables están ordenadas en una distribución a nivel mundial dónde el país con mejores indicadores en la variable tiene un puntaje de 100 y aquel con peores indicadores uno de 0. De las cinco variables analizadas, únicamente dos tienen significancia estadística para la distribución de salud al 10%. La primera de ellas es “Voz y rendición de cuentas”, que mide el grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en la selección de su gobierno y expresar sus opiniones libremente sin temor a represalias. Incluye aspectos como libertad de expresión, libertad de asociación, derechos de participación política y transparencia en la rendición de cuentas de las autoridades. Aunque en Latinoamérica no se observan efectos adicionales, se observa un coeficiente de -0.0003107 para CF hacia abajo y uno de 0.0002559 para CF hacia arriba a

nivel mundial. Esto sugiere que dicha variable reduce globalmente el nivel de desigualdad en salud entre los más pobres y el resto de la distribución pero aumenta el de los más ricos. Por otro lado, la variable de “Estabilidad Política”, que evalúa la probabilidad de que un gobierno sea derrocado, muestra un coeficiente significativo de -0.0006291 para Latinoamérica en el CF hacia abajo, aunque este no se transfiere al resto del mundo.

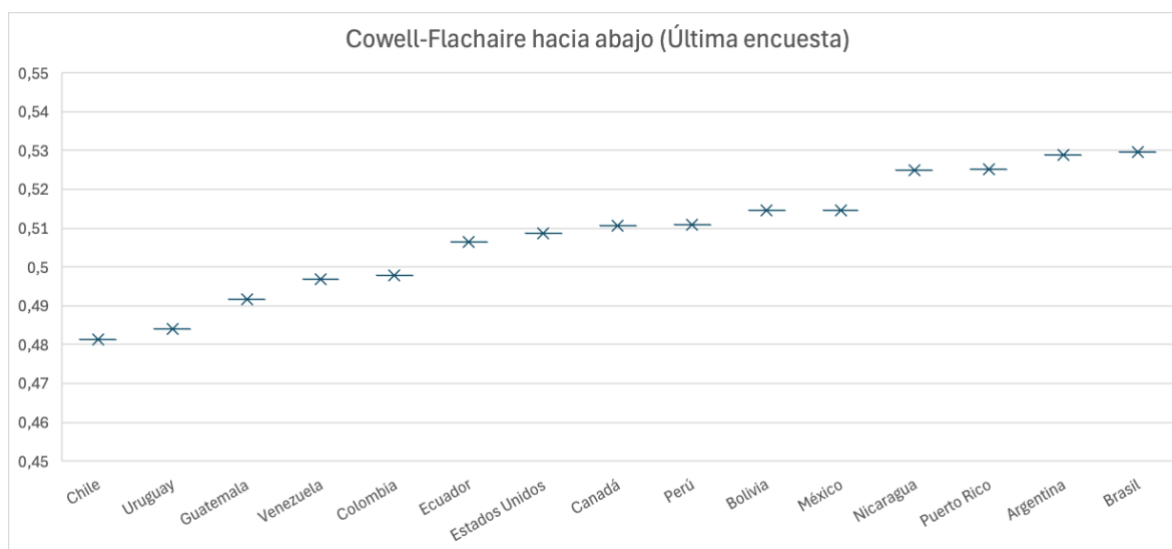
Conclusión

En línea del estudio realizado en Europa por Costa-Font y Knust (2023), quienes encuentran que la democracia reduce la desigualdad en salud al favorecer a aquellos que se encuentran en peores condiciones, este informe explora si dichos efectos se mantienen en Latinoamérica, dónde la alta desigualdad y corrupción en comparación con Europa pueden inhibir dichos beneficios. Los resultados muestran un efecto dual. Por un lado, reduce la desigualdad en salud entre aquellos que tienen peor salud. Es decir, en la parte inferior de la distribución las personas más pobres en salud están menos separadas del resto. Por otro lado, incrementa la disparidades entre aquellos que están en mejores condiciones de salud. El impacto de la exposición a la democracia no difiere significativamente de la tendencia global, lo que sugiere que los mecanismos de la democracia no están siendo inhibidos y que por tanto no se da el caso de una “trampa de desigualdad en salud”.

Por otro lado, la Voz y la rendición de cuentas parece ser un factor propio de la democracia que incide y explica parte del impacto de la democracia a nivel mundial, mientras que la Estabilidad Política explica una reducción en el CF hacia abajo de Latinoamérica respecto al escenario global. Dichos resultados dan pie a que ciertos factores de la revisión de literatura como las garantías constitucionales o el “capital democrático” de una sociedad puedan ser variables explicativas del impacto de la democracia sobre la distribución de salud.

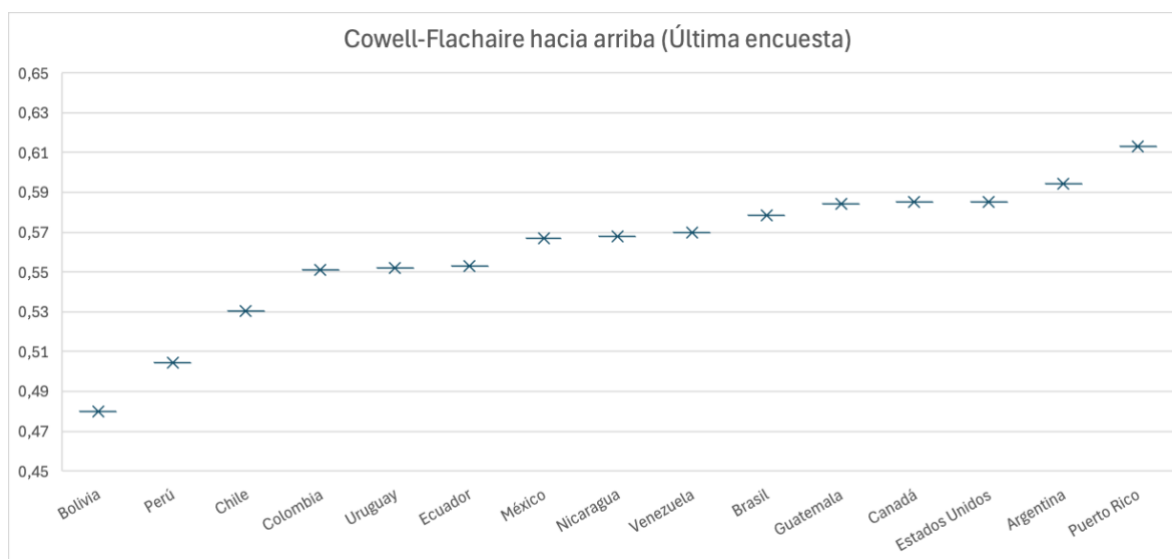
Apéndice

Figura 1:



Fuente: Elaboración Propia

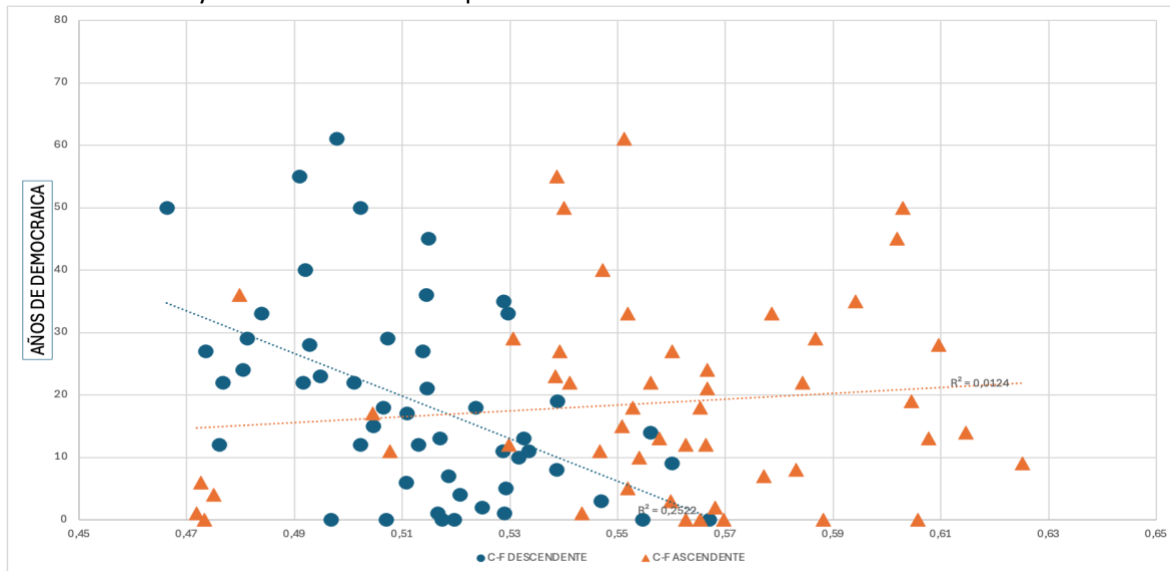
Figura 2:



Fuente: Elaboración Propia

Figura 3:

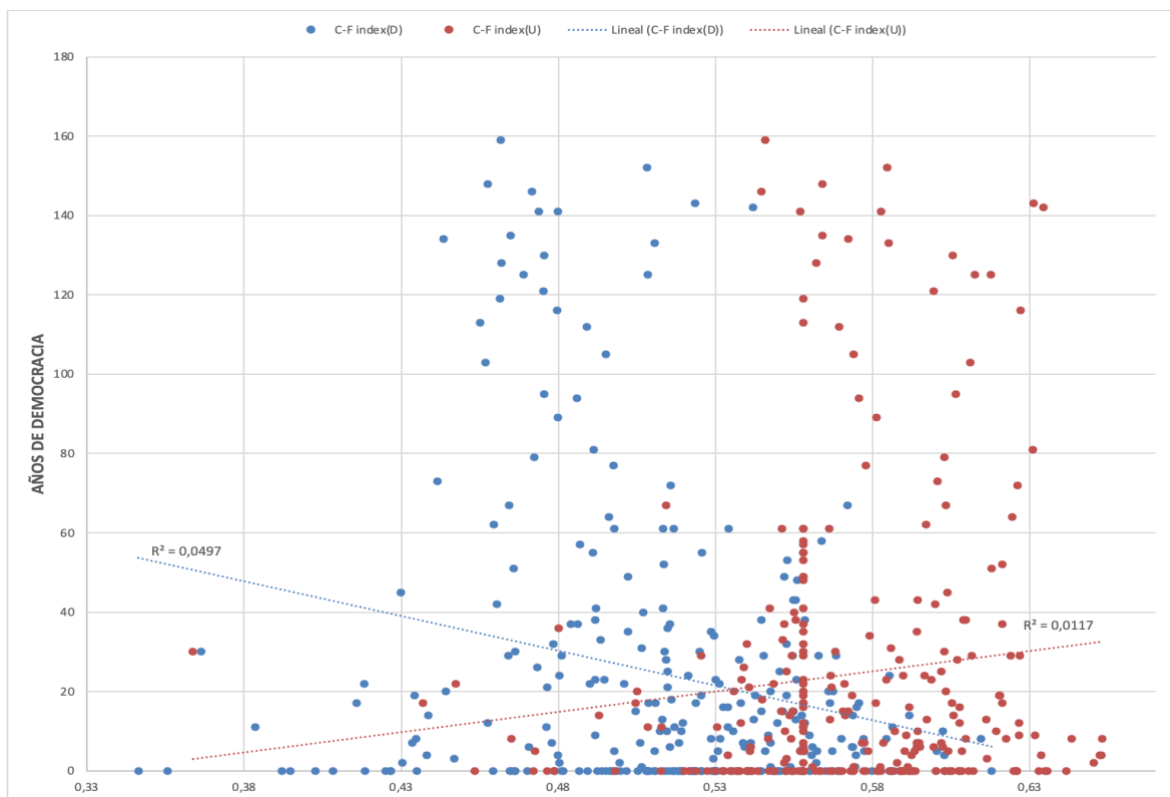
C-F ascendente y descendente en comparación con los años de democracia en Latinoamérica



Fuente: Elaboración Propia

Figura 4:

C-F ascendente y descendente en comparación con los años de democracia en el mundo



Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1

Efecto de la de exposición a la democracia en la desigualdad en salud (Cowell-Flachaire hacia abajo y arriba)

Variables	OLS (hacia abajo)	OLS (hacia abajo)	OLS (hacia arriba)	OLS (hacia arriba)
	-0.0001933**	-0.0002262***	0.0001751**	0.000115*
D_{ct}	(0.0000838)	(0.0000739)	(0.0000811)	(0.0000677)
	0.0198501**	.0189455**	-0.0215448**	-0.0331766***
Latino	(0.0095866)	(0.0109371)	(0.0092708)	(0.0124097)
	-0.0001943	-0.0001234	0.0002644	0.0005767
Latino* D_{ct}	(0.0003579)	(0.0003353)	(0.0003461)	(0.0004121)
	-7.56e-07***	-6.29e-07**	-7.39e-07***	-5.41e-07**
PIB per cápita	(2.37e-07)	(2.84e-07)	(2.29e-07)	(2.29e-07)
	0.0040192***	0.0038276***	0.0012098*	0.0010612
Mayores a 65 años (%)	(0.000684)	(0.0007912)	(0.0006614)	(0.0006596)
	-0.0013797	-0.0012719	0.0011161	0.0019828
Género masculino (%)	(0.001476)	(0.0019065)	(0.0014274)	(0.0015696)
	-0.0124843***	-0.0117782***	0.000953	0.0014222
Satisfacción por la vida	(0.0030384)	(0.0035882)	(0.0029383)	(0.0032319)
	-0.0028979	-0.0217513	-0.0027954	-0.0142567
Pandemia	(0.0114735)	(0.0247455)	(0.0110956)	(0.0123842)
	0.0379082***	0.052633	0.0261744**	0.0257152**
Año de Recesión	(0.013197)	(0.034771)	(0.0127623)	(0.0118934)
	0.6387802	0.6384892	0.5080711	0.4519999
Constante	(0.074691)	(0.0958353)	(0.0722308)	(0.0887433)
α_t	No	Si	No	Si
Observaciones	268	268	268	268
r^2 ajustado	0.3462	0.3947	0.0646	0.2631

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2

Efecto de la de exposición a la democracia y variables de Gobernanza en la desigualdad en salud en Latinoamérica y el mundo (Cowell-Flachaire hacia abajo y arriba), controlando por efectos fijos de tiempo.

Variables	Latinoamérica (hacia abajo)	Mundo (hacia abajo)	Latinoamérica (hacia arriba)	Mundo (hacia arriba)
Voz y rendición de cuentas	-0.0001249 (0.0004929)	-0.0003107* (0.0001742)	0.0001761 (0.0003575)	0.0002559* (0.0001525)
Estabilidad Política	-0.0006291* (0.0003394)	-2.36e-06 (0.0001994)	0.0001818 (0.0003145)	-0.0000545 (0.0001733)
Calidad Regulatoria	0.0002515 (0.000311)	0.0000942 (0.000213)	0.0002414 (0.0002943)	-0.000174 (0.0001709)
Estado de Derecho	-0.0000168 (0.0003349)	-0.0002783 (0.0002271)	0.0003642 (0.0002895)	-0.0001233 (0.0001886)
Control de la Corrupción	-0.0001873 (0.0003358)	-0.0001283 (0.0002122)	-0.0000522 (0.0002608)	0.000086 (0.0001759)

Fuente: Elaboración Propia

Bibliografía:

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2013). Democracy, redistribution, and inequality. *NBER Working Paper No. 19746*. National Bureau of Economic Research.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2005). *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge University Press.

Besley, T., & Kudamatsu, M. (2006). Health and democracy. *American Economic Review*, 96(2), 313-318.

Center for Systemic Peace. (2016). The Polity Project.

Costa-Font, J., & Knust, N. (2023). Does exposure to democracy decrease health inequality? *Journal of Public Policy*, 43(3), 741–760.

Costa-Font, J., Turati, G., & Batinti, A. (2020). The political economy of health and healthcare: The rise of the patient citizen. *Cambridge University Press*.

Cowell, F. A., & Flachaire, E. (2017). Inequality with ordinal data. *Economica*, 84(334), 290–321.

Eurostat. (2023). Living conditions in Europe - Income distribution and income inequality. *European Commission*.

Fondo Monetario Internacional. (2015). *Cuando los ciclos nacionales coinciden: ¿Qué sucede durante una recesión mundial?*

Krueger, P. M., Dovel, K., & Denney, J. T. (2015). Democracy and self-rated health across 67 countries: A multilevel analysis. *Social Science & Medicine*, 143, 137–144.

Marinho, M. L., Dahuabe, A., & Arenas de Mesa, A. (2023). *Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: La centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible*. Serie Políticas Sociales No. 244, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Matsuura, H. (2015). State constitutional commitment to health and health care and population health outcomes: An empirical study of 157 countries. *Constitutional Political Economy*, 26(3), 307-337.

Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. *Journal of Political Economy*, 89(5), 914-927.

Norris, P. (2012). *Making democratic governance work: How regimes shape prosperity, welfare, and peace*. Cambridge University Press.

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Pandemic prevention, preparedness and response accord: Questions and answers*.

Persson, T., & Tabellini, G. (2009). Democratic capital: The nexus of political and economic change. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 1(2), 88–126.

Powell-Jackson, T., Basu, S., Balabanova, D., McKee, M., & Stuckler, D. (2011). Democracy and growth in divided societies: A health-inequality trap? *Social Science & Medicine*, 73(1), 33–41.

Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023. *Transparency International*.

World Bank. GINI index (World Bank estimate). *World Bank Data*.

Wu, S., Wang, R., Zhao, Y., Ma, X., Wu, M., Yan, X., & He, J. (2013). The relationship between self-rated health and objective health status: A population-based study. *BMC Public Health*, 13(1), 320.